

OS CAMINHOS FREUDIANOS E O INÍCIO DA PSICANÁLISE

APRESENTAÇÃO

- **PARTE**
- [1](#)
- [2](#)
- [3](#)
-

1

apresentação

Caro aluno,

Seja bem-vindo ao estudo da disciplina **Psicanálise para Sigmund Freud e Melanie Klein**.

A proposta deste Material de Estudos e Pesquisa reúne elementos que se entendem necessários para o desenvolvimento do estudo com segurança e qualidade. Caracteriza-se pela atualidade, dinâmica e pertinência de seu conteúdo, bem como pela interatividade e modernidade de sua estrutura formal, adequadas à metodologia da Educação a Distância – EaD.

Pretende-se, com este material, levá-lo à reflexão e à compreensão da pluralidade dos conhecimentos a serem oferecidos, possibilitando-lhe ampliar conceitos específicos da área e atuar de forma competente e conscienciosa, como convém ao profissional que busca a formação continuada para vencer os desafios que a evolução científico-tecnológica impõe ao mundo contemporâneo.

Elaborou-se o presente material com a intenção de torná-la subsídio valioso, de modo a facilitar sua caminhada na trajetória a ser percorrida tanto na vida pessoal quanto na profissional. Utilize-a como instrumento para seu sucesso na carreira.

2

introdução

Este caderno de estudos tem como objetivo realizar uma apresentação da psicanálise freudiana e da psicanálise kleniana. Nosso intento será o de expor alguns dos conceitos básicos para a compreensão do pensamento destes autores, além de discutir seu fazer clínico, pois que ambos tiveram papel fundamental na construção da teoria e da técnica psicanalíticas.

Freud foi o fundador da psicanálise. Ele é uma referência obrigatória não apenas para quem quer se aprofundar nesta abordagem, mas para quem tem interesse no estudo do psiquismo humano e na constituição do pensamento moderno.

Klein foi a criadora da análise lúdica, o que levou ao desenvolvimento da psicanálise com crianças. Ela inaugurou uma nova corrente na psicanálise - a Escola Kleiniana e angariou muitos seguidores, especialmente na Inglaterra. Mezan (2013) relata que a influência de seu

pensamento foi, da década de 1940 à década de 1970, muito marcante para a psicanálise no Brasil, o que se constitui em um capítulo importante para entendermos o desenvolvimento do pensamento psicanalítico no país.

Para percorrermos as contribuições de Freud e Klein, assim dividimos este guia de estudos:

Os dois primeiros módulos tratam do pensamento freudiano. No primeiro fazemos uma retomada histórica de como surgiu a psicanálise para, ao fim, caracterizarmos o *setting* psicanalítico criado por Freud. No segundo, abordamos mais detidamente alguns dos conceitos que são fundamentais para quem deseja aprofundar-se na teoria freudiana.

Os dois últimos capítulos abordam o pensamento kleiniano. No terceiro, realizamos, assim como no primeiro, um relato histórico do surgimento da psicanálise de Klein, concluindo, da mesma forma, com a descrição do *setting kleiniano*. No quarto, encerramos nossa jornada focalizando os conceitos básicos da teoria de Klein, que representam as ideias originais que a psicanalista desenvolveu tendo como base seu fazer clínico e o pensamento freudiano.

Consideramos importante ressaltar que este guia de estudos não é suficiente como formação de um psicanalista – a prática clínica exige mais amadurecimento teórico, análise pessoal e prática de escuta supervisionada. Porém, ele se constitui sim em um começo para quem quer se aprofundar no pensamento psicanalítico – o que pode ser a entrada para uma vivência com a psicanálise mais ampla, na medida em que a teoria psicanalítica não é apenas uma ferramenta clínica, mas pode ser também uma ferramenta de compreensão do humano.

Bom caminhar para todos!

3

Objetivos

- » Propiciar ao aluno a compreensão dos diversos aspectos da teoria psicanalítica na visão de Sigmund Freud.
- » Propiciar ao aluno a compreensão dos diversos aspectos da teoria psicanalítica na visão de Melanie Klein.

EDUCACIONAL

OS CAMINHOS FREUDIANOS E O INÍCIO DA PSICANÁLISE

UNIDADE 1 | CAPÍTULO 2Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

E havia a sexualidade



1

introdução

Na medida em que avançava em suas observações clínicas, Freud começava a perceber uma constância temática nos relatos que emergiam da fala de seus pacientes. A excitação emocional que estava na base do desencadear dos sintomas neuróticos não era genérica. Ela acabava por se mostrar sempre de natureza sexual. Freud não esperava por essa constatação, e ela de fato veio a se tornar uma das principais desencadeadoras de rejeição às teorias psicanalíticas, constituindo-se em ponto principal do rompimento de Freud não apenas com Breuer, mas com nomes que viriam a desempenhar papel importante na difusão das ideias psicanalíticas (como Adler e Jung).



Clique no ícone e saiba mais

Freud, no entanto, não abriu mão de relatar aquilo que escutava na fala dos histéricos. E, sistematicamente, passou a investigar também a vida sexual de outros pacientes neuróticos, que chegavam cada vez em maior número a sua clínica, percebendo também neles a presença de fatores sexuais na emergência dos sintomas.

Freud trazia consigo a influência da teoria do trauma (de Charcot), e, por meio da fala dos histéricos, e foi levado a concluir que o trauma que se encontrava na base dos sintomas neuróticos era de origem sexual. A cena da sedução por um adulto encontrava-se presente com grande frequência na fala de seus pacientes. Nas histéricas, comumente era o pai quem ocupava o papel de sedutor. A escuta desses relatos levou Freud a formular a *Teoria*

da Sedução como explicação etiológica das neuroses. Mas o percurso do criador da psicanálise estava só no início.

A concepção da etiologia sexual das neuroses já era, em si, bastante virulenta. Porém, aquilo que veio a se descortinar em seguida era bem mais. O que as observações clínicas de Freud acabaram por desvelar vem a ser desalojador para o discurso sustentado na época sobre a sexualidade humana.

Persistindo em suas pesquisas – que, além de se calcarem sobre a escuta de seus pacientes, passam também a colher material de um intenso processo de autoanálise ao qual Freud se entrega –, o pai da psicanálise afirmará, em carta a Fliess (*veja quadro abaixo*) de 21 de setembro de 1897: “Não acredito mais em minha *neurótica* [teoria das neuroses]”.



Clique no ícone e saiba mais

Assim é que, na carta citada acima, Freud explica a Fliess que já não era possível sustentar a teoria da sedução. Vários motivos o levaram a essa conclusão. Entre eles:

Clique sobre os itens abaixo:

- A
- B
- C
- D

O abandono, por pacientes que Freud acreditava estar compreendendo, do processo de análise;

Atenção

Catexia é o termo usado em psicanálise para indicar o investimento de determinada quota de energia psíquica em um representante ideacional. Falaremos mais sobre esse tema no segundo módulo.

A chegada a este resultado deixou Freud inicialmente desestabilizado. Levou-o mesmo a pensar em abandonar todo o trabalho que vinha realizando. Passado o choque inicial, no entanto, em carta de 15 de outubro de 1897, ele finalmente expõe a ideia que sustenta três concepções fundadoras do discurso psicanalítico: a existência de uma realidade psíquica, o Complexo de Édipo e a sexualidade infantil. Eis a afirmação que Freud (1950/1990, p. 365) entrega a Fliess:



Um único pensamento de valor genérico revelou-se a mim. Verifiquei também no meu caso, a paixão pela mãe e o ciúme do pai, e agora considero isso como um evento universal do início da infância [...]. Sendo assim, pode-se entender a força avassaladora de Oedipus Rex [...], a lenda

grega capta uma compulsão que toda pessoa reconhece porque sente sua presença dentro de si mesma. Cada pessoa da plateia já foi, um dia, em germe ou na fantasia, exatamente um Édipo como esse, e cada qual recua, horrorizada, diante da realização de sonho aqui transposta para a realidade, com toda a carga de recalcamiento que separa seu estado infantil do seu estado atual.

Freud, portanto, havia esbarrado na descoberta que mais causaria indignação e geraria rejeição às ideias psicanalíticas. Ele percebera que os sintomas neuróticos não remetiam a experiências sexuais passivas ocorridas nos primeiros anos da infância. Na verdade, compunha-se a partir de fantasias, o que demonstrava a existência de uma realidade psíquica tão importante para a vida mental desses sujeitos quanto à realidade material.

Assim, clarificou-se diante dele o fato de que essas fantasias encobriam, na verdade, uma atividade auto-erótica que tinha como palco os primeiros anos da infância, desvelando-se, assim, a vida sexual das crianças – que, até então, era tida como inexistente. Freud pode, enfim, declarar: a sexualidade começa com o começo da vida.

Precisamos ressaltar, no entanto, que a teoria da sedução não é de todo abandonada por Freud. Ele a retomará posteriormente, integrando-a melhor ao corpo teórico que será construído nos anos seguintes. No ponto de equilíbrio que encontra, a criança comparece com sua sexualidade – ativa, polimorfa, livre –, mas os cuidados recebidos nos primeiros anos da infância também desempenhariam um papel fundamental, estimulando o surgimento das fantasias sexuais infantis. Haveria, portanto, uma inoculação da sexualidade adulta, por meio dos cuidados e da afeição bem própria que a mãe direcionaria a criança. Volta a figura da sedução materna/paterna pensada sob outro formato, pensada como base para as fantasias sexuais infantis, que também teriam seu estímulo em fatores constitucionais. Sobre o desenvolvimento desse aspecto no pensamento freudiano, recomendamos a leitura do primeiro capítulo de *Freud: o movimento de um pensamento*, de Luiz Roberto Monzani.

Destacado mais esse elemento fundamental para o nascimento da psicanálise propriamente dita, é chegada a hora de finalizarmos o quadro que começamos a construir no início dessa unidade: o novo saber chega, enfim, ao mundo. E agora estamos prontos para conhecer sua face.

EDUCACIONAL

OS CAMINHOS FREUDIANOS E O INÍCIO DA PSICANÁLISE

UNIDADE 1 | CAPÍTULO 3Partes

-

Bem-vindo!

Neste capítulo estudaremos

A Psicanálise chega ao mundo



1

introdução

Nessa unidade buscaremos descrever o que caracteriza, afinal, um tratamento psicanalítico.

Como vimos acompanhando nas unidades anteriores, a psicanálise se desenvolveu a partir de uma série de mudanças metodológicas que Freud foi realizando no tratamento das neuroses. A passagem do que ele denominou de “método de incitação” (1925/1990, p. 55) para a *Associação Livre* foi a última delas.

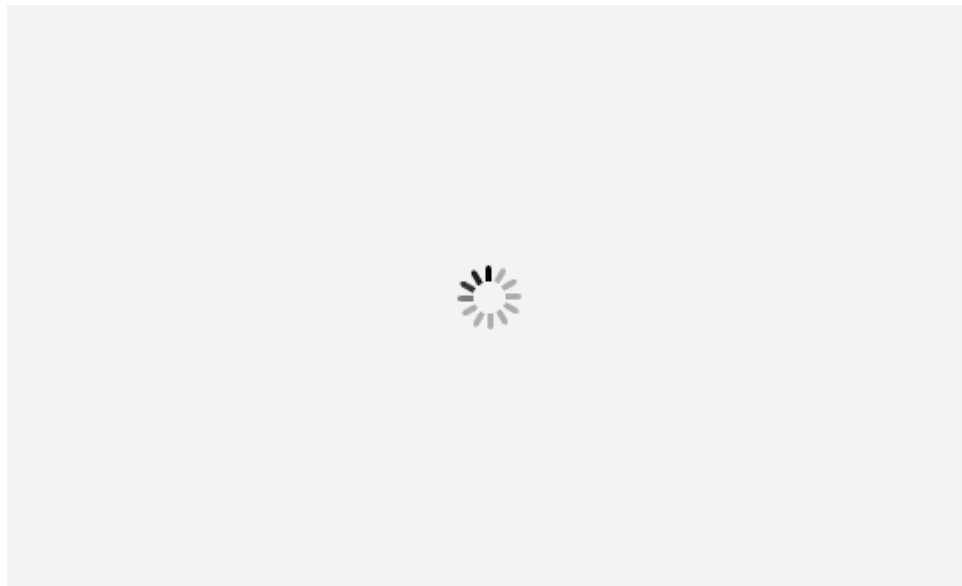
Essa passagem surge da percepção de que a técnica que vinha sendo adotada exigia um esforço demasiado do médico e do paciente. Nela, elegia-se um tema para ser desenvolvido e, pela insistência e pelo estímulo, o sujeito era incitado a falar sobre ele. O formato também era passível de críticas por estar muito próximo do uso da sugestão, o que poderia levantar dúvidas acerca do quanto às representações que ali surgiam diziam respeito ao paciente e do quanto eram frutos da condução do médico.

Curioso é que a experiência com a interpretação dos sonhos leva Freud a uma técnica que é justamente o oposto da anterior. Em vez de incitar o paciente a dizer algo sobre um assunto específico, pedia-se que ele falasse tudo o que viesse à cabeça, sem fazer objeções nem críticas, e sem fazer uma seleção prévia do conteúdo.

Associar livremente, deixar-se levar pelas representações que vão se apresentando na cadeia da fala sem impor sobre ela uma censura: essa passa a ser a *Regra Fundamental da Psicanálise*. Por meio dela, adquire-se acesso aos conteúdos inconscientes sem deixar de ter também a oportunidade de trabalhar as forças de resistência que os expulsaram da consciência. Eis o novo objetivo do tratamento criado, “revelar repressões e substituí-las por

atos de julgamento que podiam resultar quer na aceitação, quer na condenação do que fora anteriormente repudiado” (FREUD, 1925/1990, p. 43).

A psicanálise expõe para o mundo o formato definitivo de seu método de tratamento. A seguir, sintetizamos sua construção da maneira como foi apresentada até a presente unidade:



A Associação Livre é, portanto, como já havíamos afirmado a técnica que marca o início da psicanálise propriamente dita. Há imprescindível ressaltar nesse momento, seu correlato – a *Atenção flutuante* –, cuja compreensão é de importância crucial para que se entenda o quanto o novo fazer se constituirá como um campo de produção de saberes e de práticas diferenciado do lugar epistemológico no qual se inserem as psicoterapias.

Atenção flutuante diz respeito à forma como o psicanalista deve ouvir seus pacientes. Nela, ele buscaria não fixar sua escuta em um assunto específico, mantendo a mesma “atenção uniformemente suspensa” diante de todo e qualquer material surgido na fala do sujeito. Essa seria uma maneira de evitar uma ação equivocada por parte do analista: a de começar a selecionar o material que lhe é apresentado. A seleção faz com que alguns pontos se fixem em sua mente e outros sejam negligenciados. Isso é um erro porque, ao realizar essa distinção de conteúdo, o analista corre o risco de ser conduzido por suas expectativas, arriscando-se a nunca descobrir nada além do que já sabe e a falsificar aquilo que poderia vir a perceber. Limita, assim, seu acesso aos complexos inconscientes do analisando, impedindo-se de compreendê-los.

Portanto, se do paciente é exigido que ele comunique tudo o que lhe ocorre, sem censuras, do psicanalista é esperada a ação correspondente de escutar tudo o que o paciente lhe direciona, sem seleções, ou estaria desperdiçando o material entregue pelo analisando. Assim, é recomendado que ele prescinda da sua capacidade de prestar atenção (ação própria da consciência) e se abandone à “memória inconsciente”. Sobre esse importante ponto, Freud (1912/1990, p. 154) afirma que o analista:



[...] deve voltar seu próprio inconsciente, como um órgão receptor, na direção do inconsciente transmissor do paciente. [...] (Pois) o inconsciente do médico é capaz, a partir dos derivados do inconsciente que lhe são comunicados, de reconstruir esse inconsciente, que determinou as associações livres do paciente.

Essa formulação freudiana é muito importante para que se perceba a profunda diferença entre a psicanálise e outras psicoterapias. A afirmação deixa muitíssimo claro o fato de que o que entra em jogo em um processo analítico é o Inconsciente. O que se trava entre analista e analisando não é da ordem de um debate teórico ou de uma argumentação de ideias ou de um aconselhamento - e nem mesmo da simples expressão de sentimentos “de forma adequada”, como acontecia no método catártico.

Trata-se de um processo que busca que o paciente tenha contato com seus conteúdos recalçados, se dê conta das maneiras próprias que sua estruturação psíquica criou para manter tais conteúdos alijados da consciência e compreenda o porquê de a eles ter sido destinado esse fim. Por isso é que, na análise, não é suficiente ter conhecimento dos complexos inconscientes. Mais importante passa a ser se aperceber das forças que operaram para que eles se tornassem inconscientes. Ou seja, trabalhar as resistências e seus produtos.

Isso traz implicações muito específicas para o fazer psicanalítico. Freud (1912) questionará diretamente tanto o que chama de “ambição terapêutica” como o que chama de “ambição educativa”. Isso porque, segundo ele, quando se entrega ao furor *curandis*, o analista incorre no risco de concentrar seus esforços no alívio dos sintomas do paciente, quando sua atenção precisa estar voltada para o processo em si de emergência das representações inconscientes. A reapropriação dessas representações passa por uma zona de desencadeamento de incômodos e de resistências no analisando para a qual o analista ficará despreparado se sua preocupação principal for a de melhorar o estado do paciente. Por isso é que a recomendação na psicanálise seria: aborde o processo, a mudança no estado psíquico do paciente vem como decorrência.

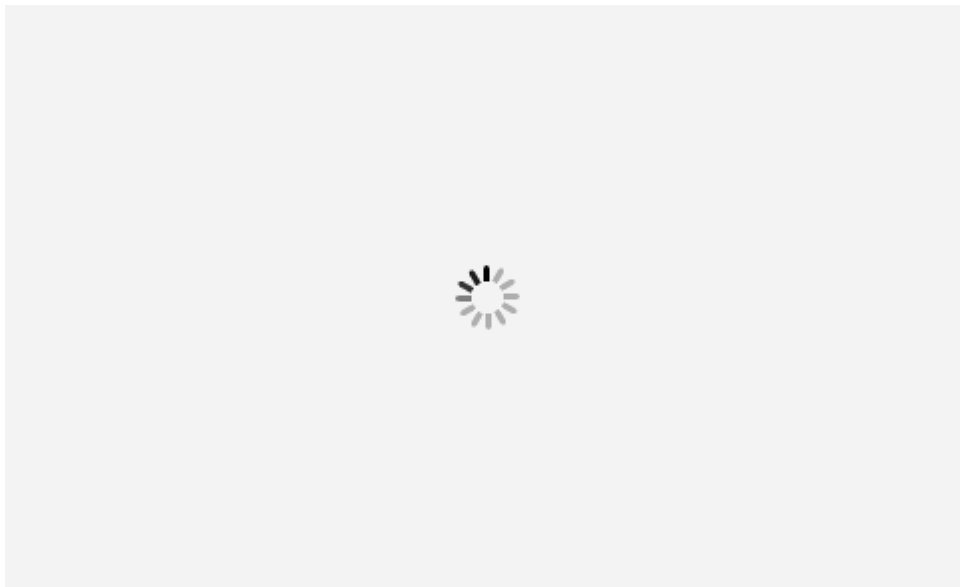
De igual inutilidade seriam as intenções educativas do analista, que costumam surgir quando seu analisando consegue por fim liberar-se de grande parte de suas inibições. O analista, ainda que o quisesse, não teria como definir os caminhos de investimento pulsional a serem tomados pelo analisando ao final de um processo – uma tentativa dessa espécie poderia inclusive, reavivar inibições que já teriam sido superadas. Por isso é que Freud alerta claramente que “o médico deve controlar-se e guiar-se pelas capacidades do paciente em vez de por seus próprios desejos” (1912/1990, p. 157).

Mas, para conseguir colocar seu inconsciente a serviço da escuta do analisando, assim como para conseguir controlar suas ambições pessoais, algo se faz fundamental: que o analista se submeta, ele mesmo, a um processo de análise, pois precisa se apropriar daqueles complexos seus que têm potencial de interferir na compreensão do inconsciente do paciente. O analista precisa trabalhar suas próprias resistências, para que elas não ocultem de sua consciência o que o inconsciente do analisando lhe apresentou. Isso será de fundamental importância para que o analista esteja pronto para enfrentar a maior dificuldade do processo analítico: o manejo da transferência.

Já tocamos nela aqui. Mas agora nos debruçaremos um pouco mais detidamente. É preciso afirmar de saída que a transferência é um fenômeno universal da mente humana, apesar de o ambiente analítico ser um espaço especialmente propício para percebê-la e tratá-la. Fato é que

ela surgirá independentemente da vontade do analista e do analisando, e se constituirá como o mais importante e difícil elemento a ser manejado na técnica analítica.

Podemos dizer que cada sujeito tem uma forma própria de amar. Em geral, nos vínculos amorosos reeditam-se as relações emocionais que tiveram origem nas primeiras ligações de objeto experienciadas. Cada um compõe uma maneira específica de se conduzir na vida erótica, e repete, no curso desta, o que se poderia chamar de um clichê amoroso, constantemente reimpresso no todo das relações que empreende com seu ambiente humano. As precondições para o enamoramento, as pulsões que se busca satisfazer nos relacionamentos, os objetivos que se estabelecem para si, tudo isso faz parte do modelo primeiro. A questão é que tal modelo não é composto unicamente por pulsões que conseguem sua satisfação na realidade e têm suas representações acessíveis à consciência. Parte dos impulsos libidinais foi retida no curso de seu desenvolvimento, ficando no âmbito do inconsciente e permanecendo, assim, afastada da realidade e da satisfação. Essas pulsões estão também na base da composição das fantasias. E as fantasias (com suas facetas conscientes e inconscientes) entram na equação que compõe a forma como o sujeito se posta em seus relacionamentos.



Não é motivo de surpresa, então, que o analista possa ser investido por essas pulsões e recoberto por essas fantasias. Freud (1912/1990, p.135) apenas ressalta o ambiente analítico como mais propício ao surgimento desse fenômeno, assim como à sua resolução.

Eis, então, o que é a transferência, uma repetição desse formato de vínculo que o sujeito estabeleceu com seus primeiros objetos de investimento libidinal. Ela surge, inicialmente, como um dos principais motores do processo analítico. Há um endereçamento de sentimentos amistosos, afetuosos e de confiança que fazem com que o analista possa iniciar seu trabalho. Esses sentimentos são precípuos para o trabalho de análise, e se colocam lado a lado de outras forças motoras, como o sofrimento do paciente e seu desejo de cura, para pôr o processo analítico em funcionamento.

No entanto, quando o conteúdo inconsciente começa a ser acessado pelo analista, ele assiste a uma transformação na transferência. Ela muda de figura e, paradoxalmente, passa a ser um dos principais pontos de resistência do analisando. Nesse momento, ela pode assumir tanto a feição de uma transferência positiva, como a feição de uma transferência negativa.

A transferência positiva, em seus prolongamentos inconscientes, remonta invariavelmente às suas fontes eróticas e pode tomar, inclusive, o formato de um arrebatado apaixonamento, que aparecerá sob os mais diversos disfarces devido ao conteúdo sexual ao qual faz remição. A transferência negativa apresenta-se na forma de sentimentos de oposição à figura do analista, e aí se manifestam na adoção das mais variadas atitudes de hostilidade.

Ambas as aparições do que Freud denominará de resistência transferencial têm o mesmo efeito: uma interrupção no processo de associação livre do analisando. Mas o que inicialmente é um transtorno ao desenvolvimento da análise passa a ser um dos mais importantes materiais do trabalho analítico, na medida em que o analista auxilia o paciente a revelar os impulsos inconscientes presentes nas ações transferenciais. Sobre essa função fundamental da análise, diz Freud (1912/1990, p.143):



O médico tenta compeli-lo a ajustar esses impulsos emocionais ao nexo do tratamento e da história de sua vida, a submetê-los à consideração intelectual e a compreendê-los à luz de seu valor psíquico. Esta luta entre o médico e o paciente, entre o intelecto e a vida instintual, entre a compreensão e a procura da ação, é travada, quase exclusivamente, nos fenômenos da transferência. É nesse campo que a vitória tem de ser conquistada – vitória cuja expressão é a cura permanente da neurose. Não se discute que controlar os fenômenos da transferência representa para o psicanalista as maiores dificuldades; mas não se deve esquecer que são precisamente eles que nos prestam o inestimável serviço de tornar imediatos e manifestos os impulsos eróticos ocultos e esquecidos do paciente. Pois, quando tudo está dito e feito, é impossível destruir alguém in absentia ou in effigie.

Por isso é que a transferência se constitui como um dos mais importantes pontos do trabalho analítico, sendo o que Freud chama de neurose transferencial um dos últimos campos a serem enfrentados na análise. A forma como se lida com ele nesse espaço é, inclusive, mais um fator que diferencia a Psicanálise de outras terapias. Como Freud ressalta (1925/1990, p. 57), o poder da sugestão que a relação transferencial confere ao médico só deve ser utilizado para induzir o paciente a realizar um trabalho psíquico, superando suas resistências e realizando uma mudança permanente em sua economia mental. Na análise, não é permitido desempenhar o papel decisivo na determinação dos resultados terapêuticos. A sugestão pode até ser utilizada, desde que a isso não se dê o nome de psicanálise.

Por fim, queremos comentar ainda que, no contínuo deste trabalho com as resistências transferenciais, encontra-se o uso do divã, que será defendido por Freud como uma forma de impedir que a transferência se misture imperceptivelmente com as associações do paciente, pois ele pode ficar preso a interpretações de gestos do analista, conduzindo a sua fala por elas. Assim, tirando a visão do analista, o paciente ficaria diante apenas de seu discurso.

Encerrando esta unidade, pontuamos aqui algumas das principais características que compõem o *setting* psicanalítico – e que o diferenciam do campo das psicoterapias em geral. Assim, é chegada a hora de partirmos para a exploração de alguns conceitos que, até então, foram apenas mencionados. Sigamos...